

SELARL LEXVOX AVOCATS · GUIDE VICTIME

PALIER PREMIUM

Kit + Audit d'avocat médical

Faites pré-analyser votre dossier.

CONÇU ET RÉDIGÉ PAR

Maître Patrice Humbert

Avocat spécialiste CNB en dommage corporel · Barreau d'Aix-en-Provence

LEXVOX

ÉDITION 2026 · LEXVOX-VICTIME.COM

Dans ce guide

Kit + Audit d'avocat médical : 4 documents.

1. Le test d'éligibilité CCI
2. Le guide de l'expertise CCI
3. Les préjudices spécifiques du contentieux médical
4. Le protocole de pré-analyse du dossier médical

Le test d'éligibilité CCI

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Ce que ce document va vous permettre

- Comprendre les trois critères de gravité qui ouvrent, ou non, la voie de la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI).
- Situer votre dossier grâce à un questionnaire en arbre de décision, avec un résultat clair en trois sorties possibles.
- Savoir quelle action concrète engager selon le résultat obtenu, sans jamais vous substituer au médecin-conseil ni à l'avocat.

Pourquoi ce test existe

Après une erreur médicale, une infection contractée à l'hôpital ou un accident lié à un soin, une question revient toujours : par quelle voie obtenir réparation ? La CCI est l'une de ces voies. C'est une procédure amiable, gratuite pour la victime, qui permet de faire reconnaître un dommage médical et de déclencher une indemnisation, sans procès immédiat.

Mais la CCI n'est pas ouverte à tous les dossiers. Le législateur a fixé un seuil de gravité. En dessous de ce seuil, la commission se déclare incompétente. Ce document vous aide à mesurer, en amont, si votre situation franchit

vraisemblablement ce seuil. Vous éviterez ainsi de vous engager dans une démarche vouée au rejet, ou au contraire de renoncer à un droit que vous possédez.

Une précision essentielle avant de commencer. Ce test est un outil de préparation. Il ne préjuge en rien de la décision de la commission. Seul un médecin-conseil, après examen, chiffre réellement vos taux. Seul un avocat confirme l'éligibilité juridique de votre dossier et choisit la stratégie la plus favorable. Le test vous donne une orientation, pas une certitude.

La logique du seuil mérite d'être comprise. La CCI n'a pas vocation à traiter tous les litiges médicaux, mais les dommages les plus graves. Le législateur a donc réservé cette procédure, plus rapide et gratuite, aux situations qui atteignent un certain niveau de sévérité. En dessous, d'autres voies existent, que ce document présente également. L'enjeu du test est donc double : ne pas saisir une commission qui se déclarera incompétente, et ne pas abandonner un dossier qui relève bien d'une autre procédure. Dans les deux cas, une orientation juste vous fait gagner du temps et préserve vos droits.

Quatre mots à comprendre avant de répondre

Le questionnaire repose sur un vocabulaire technique. Chaque terme est défini ici en une phrase.

La CCI (Commission de conciliation et d'indemnisation). C'est une commission régionale qui examine, à l'amiable, les demandes des personnes s'estimant victimes d'un dommage lié à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. L'article L1142-7 du code de la santé publique prévoit qu'elle « peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721134).

La consolidation. C'est le moment médical où votre état de santé se stabilise, où les lésions ne devraient plus évoluer, ni en mieux ni en pire. On ne peut évaluer un dommage définitif qu'à partir de la consolidation. C'est aussi le point de départ du délai de prescription : l'article L1142-28 du code de la santé publique précise que les actions et les demandes d'indemnisation « se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033810165).

L'AIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique). C'est le taux, exprimé en pourcentage, qui mesure les séquelles définitives après consolidation. Une paralysie, une perte de mobilité, un traumatisme psychologique durable se traduisent par un pourcentage d'AIPP. Ce taux est fixé par un médecin, à l'issue d'un examen.

Le DFT (déficit fonctionnel temporaire). C'est la gêne subie dans les actes de la vie quotidienne pendant la période qui précède la consolidation, tant que vous n'êtes pas encore stabilisé. Il s'exprime lui aussi en pourcentage. Un DFT de 50 % traduit une gêne majeure, par exemple une hospitalisation longue ou une immobilisation lourde qui vous prive de la moitié de vos capacités habituelles.

Le texte qui fixe le seuil

La compétence de la CCI et l'accès à la réparation au titre de la solidarité nationale reposent sur un seuil de gravité défini par l'article D1142-1 du code de la santé publique. Ce texte pose noir sur blanc les valeurs à retenir :

« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical [...] ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »

Article D1142-1 du code de la santé publique

(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023458773).

Retenez le chiffre exact : le seuil d'AIPP est fixé à **24 %**, et non 25 %. C'est la valeur réglementaire en vigueur. Le taux de 25 % que l'on rencontre parfois concerne un autre mécanisme, celui des infections nosocomiales prises en charge par la solidarité nationale, prévu par l'article L1142-1-1 du même code (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628248). Ne confondez pas les deux : pour le test d'accès à la CCI, la référence est 24 %.

Outre les deux critères chiffrés cités par le texte, l'article D1142-1 prévoit, à titre exceptionnel, deux situations d'ouverture supplémentaires : l'inaptitude définitive à l'activité professionnelle antérieure, et les troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence. Ces deux hypothèses ne reposent pas sur un pourcentage. Elles laissent une marge d'appréciation à la commission, ce qui rend l'analyse d'un avocat particulièrement utile lorsque vos taux chiffrés restent en deçà des seuils.

Le questionnaire en arbre de décision

Répondez aux questions dans l'ordre. Dès qu'une réponse vous oriente vers une sortie, vous pouvez vous y reporter. Aucune de ces réponses ne remplace un avis médical ou juridique : elle situe seulement votre dossier.

Étape préalable : votre état est-il consolidé ?

Avant tout, demandez-vous si votre état de santé est stabilisé, autrement dit consolidé. Si vous êtes encore en soins actifs, si votre situation évolue encore, les taux définitifs ne peuvent pas être fixés. Vous pouvez tout de même préparer votre dossier, mais le test ci-dessous ne donnera qu'une estimation provisoire. Un médecin détermine la date de consolidation.

Question 1 : le critère de l'AIPP

Après consolidation, un médecin a-t-il évalué, ou pensez-vous raisonnablement que sera évalué, un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique **supérieur à 24 %** ?

- **Oui, un taux supérieur à 24 % est probable.** Votre dossier remplit vraisemblablement le premier critère de gravité. Reportez-vous à la **Sortie A : CCI probable**.
- **Non, le taux semble nettement inférieur à 24 %.** Passez à la question 2, un autre critère peut s'appliquer.
- **Je ne sais pas, aucun taux n'a encore été chiffré.** Passez à la question 2, puis reportez-vous à la **Sortie B : incertain**.

Question 2 : le critère de l'arrêt d'activité ou du DFT

Votre accident médical a-t-il entraîné, pendant une durée d'au moins six mois, consécutifs ou non sur une période de douze mois, soit un arrêt temporaire de vos activités professionnelles, soit un déficit fonctionnel temporaire **égal ou supérieur à 50 %** ?

- **Oui, l'arrêt ou le DFT à 50 % a duré au moins six mois.** Votre dossier remplit vraisemblablement le deuxième critère de gravité. Reportez-vous à la **Sortie A : CCI probable**.
- **Non, la durée ou l'intensité restent en dessous.** Passez à la question 3.
- **Je ne sais pas mesurer la durée ou le pourcentage.** Passez à la question 3, puis reportez-vous à la **Sortie B : incertain**.

Question 3 : les critères exceptionnels

Vous n'atteignez ni le seuil d'AIPP, ni celui de l'arrêt d'activité. Une dernière porte reste ouverte. Votre situation correspond-elle à l'une de ces deux hypothèses exceptionnelles prévues par l'article D1142-1 ?

- Vous êtes devenu **définitivement inapte** à exercer l'activité professionnelle qui était la vôtre avant l'accident médical.
- Vous subissez des **troubles particulièrement graves** dans vos conditions d'existence, y compris d'ordre économique.
- **Oui, l'une de ces situations correspond à la mienne.** Votre dossier peut relever de la compétence exceptionnelle de la CCI, mais cette appréciation est délicate. Reportez-vous à la **Sortie B : incertain**, l'analyse d'un avocat est ici déterminante.
- **Non, aucune de ces situations ne me concerne.** Reportez-vous à la **Sortie C : autre voie**.

Les trois sorties du test

Sortie A : CCI probable

Votre dossier franchit vraisemblablement l'un des seuils de gravité de l'article D1142-1. La voie de la CCI vous est probablement ouverte. C'est une bonne nouvelle, car la saisine présente un avantage précieux : selon l'article L1142-7, « la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721134). Vous ne perdez donc pas de temps sur votre délai d'action.

Action concrète. Rassemblez votre dossier médical complet et faites confirmer vos taux par un médecin-conseil de victimes. Puis faites valider l'éligibilité et la stratégie de saisine par un avocat, avant de déposer votre demande. Ne saisissez pas seul : la constitution du dossier conditionne l'issue de l'expertise.

Sortie B : incertain

Vos taux ne sont pas encore chiffrés, ou votre situation relève des critères exceptionnels qui laissent une marge d'appréciation. Vous êtes dans une zone où le test ne peut pas trancher. C'est précisément le cas où une erreur d'orientation coûte le plus cher : renoncer à tort, ou saisir sans preuve suffisante.

Action concrète. Sollicitez une évaluation médicale de vos séquelles par un médecin-conseil, afin d'obtenir un taux d'AIPP et de DFT fiable. En parallèle, faites analyser votre dossier par un avocat, qui appréciera si les critères exceptionnels peuvent être mobilisés. Cette double lecture, médicale et juridique, lève l'incertitude.

Sortie C : autre voie

Votre dossier ne franchit vraisemblablement aucun des seuils de l'article D1142-1. Cela ne signifie pas que vous n'avez aucun droit. La CCI n'est qu'une voie parmi d'autres. La responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement peut toujours être recherchée sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique, qui pose que les professionnels de santé « ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute »

(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252). Une action amiable ou judiciaire de droit commun reste envisageable.

Action concrète. Ne classez pas votre dossier. Faites-le examiner par un avocat en dommage corporel, qui déterminera la voie la plus adaptée à votre situation, en dehors de la CCI. Un dommage sous le seuil de gravité peut être réel et réparable.

Comprendre les trois fondements possibles de votre réparation

Le seuil de gravité de l'article D1142-1 commande l'accès à la réparation au titre de la solidarité nationale, versée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, et à l'examen par la CCI. Mais l'indemnisation d'un dommage médical peut reposer sur trois fondements distincts, que l'article L1142-1 du code de la santé publique organise.

Le premier est la faute. Un professionnel ou un établissement n'est responsable, en principe, qu'en cas de faute prouvée. C'est le fondement le plus courant : retard de diagnostic, geste inadapté, défaut de surveillance. Le deuxième est l'infection nosocomiale, contractée à l'occasion d'une prise en charge, pour laquelle l'établissement répond de plein droit sauf preuve d'une cause étrangère. Le troisième est l'accident médical non fautif, appelé aussi aléa thérapeutique : aucune faute n'est commise, mais le dommage est anormal et grave. C'est ce troisième cas que la solidarité nationale a vocation à réparer, lorsque le seuil de gravité est atteint.

Pourquoi cette distinction compte-t-elle pour votre test ? Parce que le seuil de 24 %, ou de 50 % de DFT sur six mois, ouvre la porte de la solidarité nationale et de la CCI, quelle que soit l'origine du dommage. Même sans faute d'un soignant, un dommage grave peut donc être indemnisé. Inversement, un dommage sous le seuil, mais causé par une faute, reste réparable par une action de droit commun. Votre sortie du test n'épuise donc jamais la question de vos droits : elle indique seulement la voie la plus adaptée à examiner en priorité.

Ne cherchez pas à qualifier seul votre situation. Distinguer une faute d'un aléa thérapeutique, ou établir le caractère nosocomial d'une infection, suppose une expertise médicale et une lecture juridique. Le test vous situe ; le médecin-conseil et l'avocat qualifient.

Ce que ce test ne fait pas

Ce questionnaire ne chiffre pas vos taux. Il ne remplace ni l'expertise médicale, ni l'analyse juridique. Un taux d'AIPP ou de DFT ne se déduit pas d'un ressenti : il résulte d'un examen conduit par un médecin. De même, l'appréciation des critères exceptionnels suppose une lecture juridique fine du dossier. Le test vous oriente vers la bonne question et le bon interlocuteur. Il ne conclut pas à votre place. Seul un médecin-conseil et un avocat confirment l'éligibilité de votre dossier à la CCI.

Lexique

- **AIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique)** : taux, en pourcentage, mesurant les séquelles définitives après consolidation. Seuil CCI fixé à 24 %.
- **CCI (Commission de conciliation et d'indemnisation)** : commission régionale examinant à l'amiable les demandes des victimes de dommages médicaux.
- **Consolidation** : moment où l'état de santé se stabilise ; point de départ du délai de prescription de dix ans.
- **DFT (déficit fonctionnel temporaire)** : gêne dans la vie quotidienne avant consolidation, exprimée en pourcentage. Seuil CCI fixé à 50 % pendant au moins six mois.
- **Prescription** : délai au terme duquel l'action n'est plus recevable ; dix ans à compter de la consolidation en matière médicale.

Votre prochaine étape

Reportez-vous à la sortie obtenue (A, B ou C) et engagez l'unique action qu'elle indique : faire confirmer vos taux et l'éligibilité de votre dossier par un médecin-conseil et un avocat avant toute démarche.

Le cabinet LEXVOX AVOCATS accompagne les victimes de dommages corporels et d'erreurs médicales. Si le test vous laisse dans le doute, une première lecture de votre dossier par un avocat en dommage corporel vous aidera à choisir la voie juste, CCI ou autre. Nous vous recevons pour un premier échange, sans engager de démarche à votre place tant que votre situation n'a pas été analysée.

DOCUMENT 02

PALIER PREMIUM

Le guide de l'expertise CCI

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre, étape par étape, comment se déroule une procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation, de la saisine jusqu'à l'avis. - Préparer votre expertise avec méthode : pièces à réunir, récit de votre journée type, chronologie des faits, et savoir pourquoi l'assistance d'un avocat et d'un médecin-conseil est fortement recommandée. - Reconnaître les pièges qui affaiblissent un dossier, et savoir que faire de l'avis rendu puis de l'offre reçue, y compris lorsqu'elle vous paraît insuffisante.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

1. La CCI, à quoi elle sert et pour qui

La CCI est la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. C'est la définition à retenir. Il en existe une par région. Sa mission est de permettre à une victime de faire examiner un dommage médical sans engager immédiatement un procès, par une voie amiable, gratuite et encadrée par la loi.

Cette commission n'est pas un tribunal. Elle ne condamne personne. Elle organise une expertise médicale, puis rend un avis. Cet avis dit si un dommage existe, quelle en est l'origine, et qui doit en principe le réparer. Il ouvre ensuite la voie à une offre d'indemnisation. La CCI cherche donc à régler votre situation plus vite et sans les frais d'un contentieux.

À qui s'adresse cette procédure ? À toute personne qui s'estime victime d'un dommage lié à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. La loi le prévoit expressément. L'article L1142-7 du code de la santé publique dispose que « la commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ». Vos ayants droit peuvent aussi la saisir si vous êtes décédé.

Un point mérite d'être posé d'emblée. La CCI n'est compétente que pour les dommages qui atteignent un certain niveau de gravité. Ce seuil, fixé par un décret, conditionne l'accès à la procédure. Nous y revenons en détail à la fin de ce guide, car il commande aussi l'intervention de l'ONIAM. L'ONIAM est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'organisme public qui indemnise certaines victimes au titre de la solidarité nationale.

Son nom dit sa double vocation. La CCI concilie et elle indemnise. Sa mission de conciliation vise à rapprocher les points de vue et à favoriser un règlement amiable des litiges liés aux soins, y compris pour des dommages qui n'atteignent pas le seuil de gravité ouvrant la voie de l'indemnisation. Sa mission d'indemnisation, celle qui nous occupe ici, organise l'expertise puis l'avis lorsque la gravité requise est atteinte. Ce guide se concentre sur cette seconde voie, la plus fréquente pour les dommages sérieux.

Ce document ne vous promet aucun résultat. Il vous explique une procédure et vous apprend à la préparer. La qualité de votre préparation pèse lourd sur la qualité de l'avis rendu. C'est tout l'objet des pages qui suivent.

2. Le déroulement de la procédure, étape par étape

La procédure devant la CCI suit un chemin ordonné. Le connaître vous évite l'angoisse de l'inconnu et vous permet d'agir au bon moment. Voici les cinq grandes étapes.

2.1 La saisine

Tout commence par la saisine. Vous remplissez un formulaire dédié et vous l'adrez à la commission de votre région, accompagné des pièces qui décrivent votre situation médicale. La saisine est gratuite. Vous n'avez pas à avancer de frais pour être entendu.

La loi attache à cette saisine un effet protecteur essentiel. L'article L1142-7 du code de la santé publique précise que « la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ».

Source du texte : article L1142-7 du code de la santé publique,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721134

Que signifie cette phrase pour vous, concrètement ? La prescription est le délai au-delà duquel une action n'est plus recevable. Tant que la CCI est saisie et que la procédure suit son cours, ce délai est gelé. Vous ne perdez donc pas votre droit d'agir en justice pendant l'examen de votre dossier. Cette suspension vaut aussi pour les délais de recours devant le juge. Vous engagez la voie amiable sans renoncer à la voie contentieuse.

Ce mécanisme est précieux. Certaines victimes hésitent à saisir la CCI par crainte de « perdre du temps ». La loi écarte ce risque. Le temps de la procédure amiable ne joue pas contre vous.

2.2 La recevabilité

Une fois saisie, la commission examine d'abord si votre demande est recevable. Elle vérifie que votre dossier entre bien dans son champ, et notamment que le dommage atteint le seuil de gravité exigé. C'est un filtre. Une demande qui ne franchit pas ce seuil sera déclarée irrecevable, sans expertise.

Cette étape explique pourquoi votre dossier de saisine doit être soigné. Un dossier incomplet ou imprécis peut conduire la commission à mal apprécier la gravité de votre état. Nous détaillons plus loin les pièces à réunir. Retenez pour l'instant que la recevabilité se joue en grande partie sur ce que vous produisez au départ.

Si la demande est jugée recevable, la commission passe à l'organisation de l'expertise. Si elle ne l'est pas, elle vous l'indique. Une irrecevabilité ne vous prive pas de vos autres voies de droit, en particulier de l'action devant le juge.

2.3 La désignation de l'expert

Vient ensuite la désignation de l'expert. La commission choisit un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner votre situation. L'expert n'est pas votre médecin traitant. Ce n'est pas non plus le médecin de l'établissement mis en cause. C'est un tiers, désigné pour son indépendance et sa compétence dans la spécialité concernée.

Sa mission est définie par la commission. L'expert doit décrire votre état, dire si un manquement ou un accident médical est à l'origine de votre dommage, et évaluer les conséquences de ce dommage poste par poste. Il travaille à partir de votre dossier médical, de son examen clinique et de ce que chacun lui expose le jour de la réunion.

Vous êtes informé du nom de l'expert et de la date de la réunion d'expertise. Ce moment est central. C'est autour de lui que se joue une grande partie de votre indemnisation future.

2.4 La réunion d'expertise

La réunion d'expertise est le rendez-vous où l'expert vous examine et recueille les positions de chacun. Vous y êtes convoqué. L'établissement ou le professionnel mis en cause y est également représenté, souvent par son propre médecin-conseil. L'assureur peut être présent.

Cette réunion est contradictoire. Nous expliquons ce terme au chapitre suivant, car il est déterminant. Retenez ici que chaque partie peut s'exprimer, présenter ses pièces et discuter les constats de l'expert. Vous n'êtes pas un simple objet d'examen. Vous êtes une partie à part entière, qui a le droit d'être entendue et assistée.

L'expert vous examine, consulte votre dossier, écoute les échanges, puis se retire pour rédiger son rapport. Ce rapport décrit vos préjudices et propose des évaluations. Il évoquera des notions techniques comme la consolidation, le DFT ou l'AIPP, que ce guide définit. Le rapport est ensuite transmis à la commission et communiqué aux parties.

2.5 L'avis de la commission

Sur la base du rapport d'expertise, la commission rend son avis. C'est l'aboutissement de la procédure. L'avis se prononce sur l'existence d'un dommage réparable, sur son origine, et sur la personne tenue de le réparer. Il indique en principe si votre dommage relève d'une faute, d'une infection contractée dans l'établissement, ou d'un aléa relevant de la solidarité nationale.

Cet avis n'est pas une condamnation. Il n'a pas la force d'un jugement. Mais il enclenche la phase d'indemnisation : l'assureur du responsable, ou l'ONIAM selon le cas, doit ensuite vous faire une offre. Nous détaillons les suites de l'avis dans le dernier chapitre.

De la saisine à l'avis, cette procédure demande plusieurs mois. Le temps de l'expertise, celui de la transmission du rapport, puis celui de la délibération de la commission s'additionnent. Cette durée n'est pas du temps perdu. Elle vous laisse préparer chaque étape, réunir vos pièces, et faire valoir vos observations. Elle est en tout cas plus rapide et moins coûteuse qu'un procès. Rappelez-vous surtout que la saisine a gelé vos délais : la patience de la voie amiable ne se paie pas de la perte de vos droits. La patience et la préparation sont vos meilleures alliées.

3. La composition de la CCI et le caractère contradictoire de l'expertise

3.1 Une commission composée de plusieurs regards

La CCI n'est pas une personne seule. C'est une formation collégiale, réunissant plusieurs membres aux profils différents. On y trouve notamment des magistrats, des représentants des usagers du système de santé, des représentants des professionnels et des établissements de santé, des représentants des assureurs et de l'ONIAM, ainsi que des personnalités qualifiées.

Cette diversité a un sens. Elle vise à ce que votre situation soit examinée sous plusieurs angles, et non par un seul intérêt. La présence de représentants des usagers, c'est-à-dire des patients, assure que la voix des victimes est représentée dans la formation qui rend l'avis. La présidence est en principe confiée à un magistrat, garant de l'impartialité de la procédure.

Vous n'avez pas à retenir la composition exacte. Retenez l'idée : la commission est plurielle, encadrée par un magistrat, et conçue pour équilibrer les points de vue. Cela ne vous dispense pas de défendre le vôtre avec méthode.

3.2 Le caractère contradictoire, votre meilleure garantie

L'expertise devant la CCI est contradictoire. Ce mot technique désigne un principe simple et protecteur. Le contradictoire, c'est le droit, pour chaque partie, de connaître les éléments du dossier, d'y répondre, et de discuter les constats avant qu'une décision ne soit prise. Rien ne peut vous être opposé sans que vous ayez pu en débattre.

Concrètement, ce principe vous donne plusieurs droits. Vous avez le droit d'être convoqué à la réunion d'expertise. Vous avez le droit d'accéder aux pièces produites par les autres parties. Vous avez le droit de présenter vos propres pièces et vos observations. Vous avez le droit d'être assisté par les personnes de votre choix, notamment un avocat et un médecin-conseil.

Le contradictoire s'exerce aussi après la réunion. L'expert établit fréquemment un pré-rapport, ou note de synthèse, qu'il soumet aux parties avant de finaliser son travail. Ce moment est une occasion précieuse. Vous, ou vos conseils, pouvez adresser à l'expert des observations écrites, que l'on appelle des dires. L'expert doit en tenir compte et y répondre dans son rapport définitif.

Un dire bien construit peut corriger une erreur, faire valoir un préjudice oublié, ou contester une évaluation trop basse. C'est un levier réel. Encore faut-il savoir le manier. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'assistance d'un avocat et d'un médecin-conseil change souvent l'issue de l'expertise.

Le caractère contradictoire n'a de valeur que si vous l'exercez. Un droit qui reste inutilisé ne protège personne. Une victime présente, assistée, qui pose ses pièces et formule ses dires, tient sa place. Une victime absente ou muette la laisse à d'autres.

4. L'assistance par un avocat et un médecin-conseil

4.1 Pourquoi cette assistance est fortement recommandée

La procédure CCI est gratuite et vous pouvez vous y présenter seul. Mais en face de vous, les autres parties ne viennent jamais seules. L'établissement de santé, le professionnel mis en cause et son assureur sont défendus par des juristes et par des médecins-conseils dont c'est le métier. L'équilibre réel du contradictoire suppose que vous soyez, vous aussi, assisté.

Deux assistances sont ici complémentaires. L'avocat maîtrise le droit de la réparation du dommage corporel, la stratégie du dossier et la rédaction des dires. Le médecin-conseil de victime, un médecin indépendant qui défend vos intérêts, maîtrise le langage médical de l'expert et discute d'égal à égal les constats cliniques. L'un sans l'autre laisse un angle mort. Ensemble, ils couvrent le terrain juridique et le terrain médical.

Le rôle du médecin-conseil est souvent décisif le jour de la réunion. C'est lui qui repère qu'un poste de préjudice est sous-évalué, qu'une séquelle est minimisée, ou qu'une date de consolidation est fixée trop tôt. L'expert et le médecin de la partie adverse parlent une langue technique. Sans un médecin de votre côté, vous n'êtes pas en mesure de la contester.

Le rôle de l'avocat s'étend sur toute la procédure. Il vérifie la recevabilité, prépare le dossier de saisine, vous prépare à la réunion, rédige les dires après le pré-rapport, puis analyse l'avis et l'offre qui en découle. Il veille aussi au respect de vos délais et de vos droits. Son regard transforme une démarche subie en une démarche maîtrisée.

Aucune loi ne vous oblige à cette double assistance. Mais l'expérience du contentieux médical montre qu'un dossier assisté est mieux armé qu'un dossier isolé. Ce guide vous recommande donc, fortement, de ne pas affronter seul cette étape.

4.2 Comment la préparer

Préparer votre assistance, c'est vous en entourer tôt, avant la réunion, et non la veille. Voici comment vous y prendre.

Prenez contact avec un avocat en réparation du dommage corporel dès que vous envisagez la saisine, ou dès que vous êtes convoqué à l'expertise si la procédure est déjà lancée. Plus tôt vous le consultez, mieux votre dossier de saisine sera construit et plus votre préparation à la réunion sera solide.

Réunissez avec lui votre dossier médical complet. L'avocat et le médecin-conseil ont besoin de lire l'ensemble des pièces pour repérer les points forts et les fragilités. Un dossier remis au dernier moment ne peut pas être exploité utilement.

Demandez à votre avocat s'il travaille avec un médecin-conseil de victime, ou faites-vous indiquer un praticien indépendant. Prévoyez que ce médecin étudie votre dossier avant la réunion et, dans l'idéal, qu'il soit présent le jour de l'expertise pour dialoguer avec l'expert.

Préparez ensemble la réunion. Passez en revue les préjudices à faire valoir, les questions que l'expert posera, les pièces à mettre en avant, et la manière de décrire votre quotidien sans le minimiser. Cette répétition n'est pas de la comédie. C'est l'assurance de ne rien oublier sous le stress du rendez-vous.

Enfin, gardez à l'esprit que ce guide n'a pas vocation à remplacer cette assistance. Il vous prépare à en tirer le meilleur parti.

5. La préparation concrète de la victime

Même bien entouré, vous restez la source première de l'information. Personne ne connaît votre quotidien mieux que vous. Votre préparation personnelle nourrit celle de vos conseils et donne à l'expert une image fidèle de votre situation. Voici comment la construire.

5.1 Réunir vos pièces

Un dossier se gagne d'abord sur les pièces. Rassemblez, classez et datez tout ce qui documente votre parcours depuis l'acte médical en cause. Voici les grandes familles de pièces à réunir.

Votre dossier médical. C'est la pièce maîtresse. Comptes rendus d'hospitalisation, comptes rendus opératoires, résultats d'examens, imagerie, ordonnances, courriers entre médecins. Vous avez un droit d'accès à ces documents. Si vous ne les avez pas encore, demandez-les à l'établissement et aux praticiens.

Les preuves de votre suivi et de vos soins. Certificats médicaux, arrêts de travail, comptes rendus de rééducation, prescriptions de matériel, factures de soins et de transports. Ces pièces montrent la réalité et la durée de vos souffrances et de vos traitements.

Les traces de vos préjudices non médicaux. Justificatifs de pertes de revenus, aménagements du logement ou du véhicule, aide reçue de vos proches, dépenses engagées à cause de votre état. Tout ce qui a un coût ou une conséquence dans votre vie doit être documenté.

Vos éléments personnels de suivi. Un journal de vos douleurs, de vos difficultés quotidiennes, de vos rendez-vous, des photos si elles sont pertinentes. Ces éléments, tenus dans le temps, donnent chair à votre dossier.

Classez ces pièces par ordre chronologique et faites-en un exemplaire pour vos conseils. Un dossier ordonné se lit vite et se défend mieux qu'un tas de documents éparés.

5.2 Écrire le récit de votre journée type

L'expert doit comprendre ce que votre vie est devenue. Pour cela, rien n'est plus parlant que le récit de votre journée type. Décrivez, heure par heure, une journée ordinaire depuis votre dommage. Le lever, la toilette, l'habillage, les repas, les déplacements, le travail ou son impossibilité, les temps de repos imposés par la douleur, le coucher.

Pour chaque moment, dites ce que vous ne pouvez plus faire seul, ce qui vous coûte, ce qui vous fait souffrir, et qui vous aide. Ne racontez pas votre meilleur jour. Ne racontez pas non plus votre pire jour. Décrivez une journée représentative, honnête, telle que vous la vivez vraiment.

Ce récit sert deux fins. Il vous prépare à répondre à l'expert sans rien oublier sous l'émotion. Et il fournit à vos conseils une base concrète pour identifier chaque poste de préjudice. Un ressenti diffus ne se défend pas. Une journée décrite avec précision se défend.

5.3 Établir votre chronologie

Construisez enfin une chronologie claire des faits. Sur une seule page, alignez les dates qui comptent : l'acte médical en cause, l'apparition des premiers symptômes ou complications, les hospitalisations, les interventions, les périodes d'arrêt, les étapes de votre parcours jusqu'à aujourd'hui.

Cette chronologie est un outil de lisibilité. Elle permet à l'expert et à la commission de saisir en un coup d'oeil l'enchaînement des événements. Elle met en lumière le lien entre l'acte contesté et vos dommages. Elle évite les confusions de dates qui affaiblissent un dossier.

Datez chaque étape avec le plus de précision possible, en vous appuyant sur vos pièces. Une chronologie sourcée, cohérente avec votre dossier médical, inspire confiance. Une chronologie approximative sème le doute.

6. Les pièges à éviter

Certaines erreurs reviennent d'un dossier à l'autre. Elles ne relèvent pas de la malchance mais du défaut de préparation. Les connaître, c'est déjà les éviter.

6.1 Minimiser son état

C'est le piège le plus fréquent et le plus coûteux. Beaucoup de victimes, par pudeur, par courage ou par habitude de « faire face », minimisent leurs difficultés devant l'expert. Elles disent que « ça va », qu'elles « se débrouillent », qu'elles « ne veulent pas se plaindre ».

Cette attitude, humainement respectable, se retourne contre vous. L'expert évalue ce qu'il constate et ce que vous décrivez. S'il vous entend dire que tout va bien, il l'écrira. Le rapport reflétera un état minoré, et votre indemnisation avec lui. Vous n'êtes pas là pour vous plaindre. Vous êtes là pour décrire la vérité de votre situation, y compris ce qui vous coûte et ce qui vous humilie.

Décrivez donc vos difficultés sans les gonfler et sans les taire. La sincérité complète, ni exagération, ni minimisation, est votre meilleure ligne de conduite. Un médecin-conseil à vos côtés vous aide précisément à tenir cette ligne.

6.2 Présenter un dossier incomplet

Le deuxième piège est le dossier lacunaire. Une pièce manquante, c'est un préjudice qui ne se prouve pas. Un compte rendu oublié, une facture égarée, un justificatif d'aide non produit, et le poste correspondant risque d'être écarté ou sous-évalué.

L'expert et la commission raisonnent sur ce qui est produit. Ce qui n'est pas au dossier n'existe pas à leurs yeux. La règle est donc simple : mieux vaut trop de pièces que pas assez, à condition qu'elles soient classées et lisibles. Vérifiez votre dossier poste par préjudice. À chaque difficulté que vous décrivez, associez une preuve.

6.3 Se présenter sans assistance

Le troisième piège est l'isolement. Affronter seul une expertise, face à des parties adverses assistées de juristes et de médecins-conseils, place le dossier en déséquilibre. Vous ne connaissez ni le langage technique de l'expert, ni les leviers de la procédure, ni la manière de formuler un dire.

Ce déséquilibre ne se voit pas toujours sur le moment. Il se paie plus tard, dans un avis moins favorable et une offre plus basse. L'assistance n'est pas un luxe procédural. C'est le moyen d'exercer réellement le contradictoire que la loi vous accorde. Ne vous privez pas de ce moyen par excès de confiance ou par crainte des honoraires. Une première consultation permet d'en parler.

6.4 Négliger le pré-rapport

Un dernier piège, plus discret, guette même les victimes assistées : laisser passer le pré-rapport sans réagir. Le pré-rapport de l'expert est l'ultime occasion de corriger le tir avant l'avis. Le lire vite, ou ne pas y répondre, revient à accepter par défaut des constats que vous auriez pu discuter. Chaque pré-rapport mérite une lecture attentive et, si nécessaire, un dire.

7. Les suites : l'avis, l'offre, et que faire d'une offre insuffisante

7.1 L'avis de la commission

À l'issue de l'expertise, la commission rend son avis. Cet avis qualifie votre situation. Il dit si votre dommage résulte d'une faute d'un professionnel ou d'un établissement, d'une infection contractée à l'occasion des soins, ou d'un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale.

Cette qualification n'est pas un détail. Elle désigne qui doit vous indemniser. Si une faute est retenue, c'est l'assureur du responsable qui doit faire une offre. Si votre dommage relève de la solidarité nationale, c'est l'ONIAM. La loi organise ces deux voies.

L'article L1142-1 du code de la santé publique pose ces fondements. Il retient d'abord la responsabilité pour faute des professionnels et des établissements. Il ajoute que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». Une infection nosocomiale est une infection contractée à l'occasion d'une prise en charge dans un établissement de santé. Enfin, en son second paragraphe, ce texte ouvre la réparation par la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs présentant un caractère de gravité suffisant.

Source du texte : article L1142-1 du code de la santé publique,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252

7.2 Le seuil de gravité qui commande la compétence de la CCI et l'ONIAM

C'est ici qu'intervient une notion capitale, annoncée dès le début de ce guide. La compétence de la CCI, comme l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, suppose que votre dommage atteigne un seuil de gravité. Ce seuil est fixé par décret.

L'article D1142-1 du code de la santé publique le précise. Il dispose que « le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % ». Ce pourcentage vise le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. L'AIPP est l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, c'est-à-dire le taux, exprimé en pourcentage, qui mesure vos séquelles définitives après consolidation.

Le même article prévoit d'autres portes d'entrée que le seuil de 24 %. Il retient aussi le caractère de gravité pour un accident médical « ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ». Le DFT est le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante subie avant la consolidation, pendant la période des soins.

Source du texte : article D1142-1 du code de la santé publique,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023458773

Retenez bien ce chiffre : le seuil d'AIPP est de 24 %, et non de 25 %. C'est la valeur réglementaire en vigueur. En deçà de ce seuil, et hors les autres cas de gravité prévus par le texte, la CCI n'est pas compétente et la solidarité nationale ne joue pas. Votre médecin-conseil et votre avocat apprécient avec vous si votre situation atteint ce niveau. C'est l'un des enjeux majeurs de la recevabilité et de l'expertise.

Quand le seuil est atteint et qu'aucune faute n'est retenue, la réparation relève de la solidarité nationale, mise en oeuvre par l'ONIAM. Ce mécanisme permet d'indemniser des victimes d'accidents médicaux graves alors même que personne n'a commis de faute. C'est une protection importante, propre au droit français de la santé.

7.3 L'offre de l'assureur ou de l'ONIAM

Après l'avis, la phase d'indemnisation s'ouvre. Selon la qualification retenue, l'assureur du responsable ou l'ONIAM doit vous adresser une offre d'indemnisation. Cette offre chiffre les sommes proposées pour réparer vos différents

postes de préjudice, définis à partir du rapport d'expertise.

L'offre s'appuie sur l'évaluation de vos préjudices poste par poste. La consolidation joue ici un rôle clé. La consolidation est le moment où votre état de santé se stabilise et n'évolue plus, où les séquelles se fixent. Elle sépare les préjudices temporaires, subis avant elle, des préjudices permanents, subis après. Tant que vous n'êtes pas consolidé, seule une indemnisation provisionnelle, c'est-à-dire une avance, peut en principe être envisagée.

Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre qui vous est faite. L'accepter vaut règlement de votre indemnisation pour les postes concernés. C'est une décision lourde, qui mérite d'être pesée avec vos conseils avant toute signature.

7.4 Que faire d'une offre insuffisante

Il arrive qu'une offre paraisse basse au regard de vos préjudices réels. Que faire dans ce cas ? D'abord, ne signez rien sous la pression. Une offre n'est pas un ordre. C'est une proposition, que vous êtes libre de discuter ou de refuser.

Faites analyser l'offre par votre avocat et votre médecin-conseil. Ils comparent, poste par poste, les sommes proposées avec l'évaluation de vos préjudices. Ils repèrent les postes oubliés, les évaluations minorées, les erreurs de calcul. Cette analyse dit si l'offre est acceptable, discutable ou nettement insuffisante.

Si l'offre est insuffisante, plusieurs voies s'ouvrent. Vous pouvez la contester et négocier une revalorisation. Vous pouvez aussi refuser et porter votre demande devant le juge, qui appréciera souverainement votre indemnisation. Rappelez-vous ici l'effet de la saisine de la CCI : elle a suspendu vos délais de prescription et de recours. Vous n'avez donc pas perdu votre droit d'agir en justice pendant la procédure amiable.

Une observation générale, tirée de la pratique du cabinet, éclaire cette étape. Les offres spontanées sont fréquemment inférieures à l'indemnisation réelle qu'une victime obtient avec l'assistance d'un avocat spécialisé. Une offre insuffisante n'est donc pas une fatalité. C'est souvent un point de départ de négociation, à condition d'être défendu avec méthode et compétence.

Conformément à l'article 11.1 du Règlement Intérieur National, l'avocat est tenu à une obligation de moyens, non de résultat. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Chaque situation est unique.

Lexique

CCI : commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Instance régionale, amiable et gratuite, qui organise une expertise et rend un avis sur un dommage médical.

ONIAM : Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Organisme public qui indemnise certaines victimes au titre de la solidarité nationale, notamment en l'absence de faute.

Solidarité nationale : mécanisme par lequel la collectivité, via l'ONIAM, indemnise des accidents médicaux graves non fautifs, alors même que personne n'a commis de faute.

Contradictoire : principe garantissant à chaque partie le droit de connaître les pièces du dossier, d'y répondre et de discuter les constats avant qu'une décision ne soit prise.

Dire : observation écrite adressée à l'expert, avant son rapport définitif, pour contester ou compléter ses constats. L'expert doit y répondre.

AIPP : atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Taux, en pourcentage, mesurant les séquelles définitives après consolidation. Le seuil de compétence de la CCI est fixé à 24 %.

DFT : déficit fonctionnel temporaire. Gêne dans les actes de la vie courante subie avant la consolidation, pendant la période des soins.

Consolidation : moment où l'état de santé se stabilise et n'évolue plus. Il sépare les préjudices temporaires des préjudices permanents.

Infection nosocomiale : infection contractée à l'occasion d'une prise en charge dans un établissement de santé.

Médecin-conseil de victime : médecin indépendant qui assiste et défend la victime lors de l'expertise, face à l'expert et au médecin de la partie adverse.

Provision : avance sur indemnisation, versée avant la consolidation, lorsque le préjudice n'est pas encore définitivement évaluable.

Votre prochaine étape Avant votre réunion d'expertise, réunissez et classez votre dossier médical complet, rédigez le récit de votre journée type et votre chronologie, puis faites-vous assister par un avocat et un médecin-conseil de victime.

L'expertise CCI se prépare, elle ne s'improvise pas. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié à la réparation du dommage corporel et à la responsabilité médicale, accompagne les victimes dans la préparation de cette étape et la défense de leurs droits devant la commission. Si vous souhaitez faire le point sur votre situation et envisager la suite, une première consultation permet d'en parler, sans engagement.

DOCUMENT 03

PALIER PREMIUM

Les préjudices spécifiques du contentieux médical

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre la perte de chance, ce préjudice qui répare la chance perdue d'éviter un dommage, et savoir pourquoi son indemnisation n'est qu'une fraction du préjudice total. - Comprendre le préjudice d'impréparation, ce préjudice autonome né du défaut d'information, consacré par la Cour de cassation. - Distinguer clairement ces deux préjudices, qui répondent à deux logiques différentes et peuvent se cumuler.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

1. Deux préjudices que l'on ne rencontre qu'en matière médicale

Le contentieux médical répare, comme tout dommage corporel, les postes classiques : les souffrances, l'incapacité, la perte de revenus, l'aide humaine. Vous les retrouvez dans la nomenclature Dintilhac, qui est la liste de référence des postes de préjudice utilisée par les experts et les tribunaux. Ces postes ne sont pas propres au médical. Ils valent aussi pour un accident de la route ou du travail.

Mais le contentieux médical fait naître deux préjudices d'un genre particulier, que vous ne croiserez presque jamais ailleurs. La perte de chance. Le préjudice d'impréparation. Ces deux notions déroutent souvent les victimes. Elles reposent sur une idée commune : en matière de santé, le dommage ne tient pas seulement à ce qui s'est produit, mais aussi à ce qui aurait pu se produire autrement.

Ces deux préjudices partagent une racine. Ils naissent tous deux d'un manquement du professionnel de santé, souvent un manquement à son devoir d'information ou à la rigueur du diagnostic. Mais ils ne réparent pas la même chose. La perte de chance répare une occasion manquée d'échapper au dommage. L'impréparation répare le choc de subir un risque auquel personne ne vous avait préparé.

Ce document vous explique chacun de ces deux préjudices, avec des exemples concrets, puis vous montre comment les distinguer. Il ne vous donne aucun montant. Le chiffrage relève de votre avocat et de l'expertise médicale. Il vous donne les clés pour comprendre ce que votre dossier peut contenir, et pour ne pas laisser passer un préjudice réel faute de l'avoir identifié.

2. La perte de chance : réparer l'occasion manquée

La définition à retenir

La perte de chance est le préjudice qui naît lorsqu'une faute a privé le patient d'une chance d'éviter le dommage ou d'y échapper. La faute n'a pas forcément causé, à elle seule, tout le dommage final. Mais elle a supprimé une possibilité favorable qui existait. Cette possibilité perdue a une valeur. Le droit la répare.

Prenez un instant pour bien saisir la nuance. Dans beaucoup de dossiers médicaux, il est impossible d'affirmer que, sans la faute, tout se serait bien passé. La maladie était là. Le risque existait. Ce que la faute a fait, c'est réduire ou anéantir les chances du patient de s'en sortir mieux. Voilà ce que la perte de chance vient saisir : non pas la certitude d'un dommage évité, mais la probabilité perdue d'un meilleur sort.

L'indemnisation n'est qu'une fraction du préjudice total

Voici le point le plus important, et le plus souvent mal compris. La perte de chance ne se répare jamais à 100 %. Elle se répare à hauteur de la chance perdue, exprimée en pourcentage du préjudice total.

Le raisonnement est le suivant. Le juge évalue d'abord l'ensemble du dommage subi, comme s'il devait être indemnisé en totalité. Puis il détermine quelle était la probabilité, sans la faute, d'échapper à ce dommage. Cette probabilité devient le taux de la perte de chance. L'indemnisation correspond alors à cette fraction, et à elle seule.

Un exemple chiffré rend la mécanique claire, étant précisé qu'il s'agit d'une simple illustration de méthode et non d'un montant garanti. Supposons un préjudice total évalué à une certaine somme. Si l'expertise retient que le patient

avait, sans la faute, 40 % de chances d'éviter ce dommage, la réparation portera sur 40 % de la somme, pas sur la totalité. Les 60 % restants correspondent à la part du dommage qui se serait probablement produite de toute façon, indépendamment de la faute. Le droit ne les met pas à la charge du professionnel.

Cette règle de la fraction est déroutante quand on la découvre. Elle peut sembler sévère. Elle est en réalité protectrice et logique. Elle permet d'indemniser un patient même lorsque le lien entre la faute et le dommage n'est pas total, là où une exigence de certitude absolue le laisserait sans rien. Sans la perte de chance, beaucoup de victimes médicales n'obtiendraient aucune réparation, faute de pouvoir prouver que la faute a causé, seule et entièrement, leur dommage.

Exemple 1 : le retard de diagnostic

Le cas le plus fréquent de perte de chance est le retard de diagnostic. Un patient consulte pour des symptômes. Le professionnel ne décèle pas à temps la maladie, ou tarde à prescrire l'examen qui l'aurait révélée. Quand le diagnostic tombe enfin, la maladie a progressé.

Ici, la faute n'a pas créé la maladie. Elle existait déjà. Mais le retard a fait perdre au patient une chance de bénéficier plus tôt d'un traitement, à un stade où ses chances de guérison ou de rémission étaient supérieures. Cette chance perdue est le préjudice. Elle se mesure en comparant la situation réelle du patient et celle qui aurait probablement été la sienne avec un diagnostic posé à temps.

Notez la prudence du raisonnement. On ne dit pas que le patient aurait guéri. On dit qu'il a perdu une chance d'un meilleur pronostic. C'est cette chance, évaluée en pourcentage, qui est indemnisée.

Exemple 2 : le défaut d'information ayant privé du choix de refuser l'acte

Deuxième situation classique. Un professionnel réalise un acte, une intervention par exemple, sans avoir correctement informé le patient des risques. L'un de ces risques se réalise et cause un dommage.

Si le patient démontre que, correctement informé, il aurait pu refuser l'acte ou le reporter, alors le défaut d'information lui a fait perdre une chance d'échapper au dommage. Cette chance perdue, c'est celle de ne pas subir l'acte, donc de ne pas s'exposer au risque qui s'est réalisé. Là encore, la réparation se fait à hauteur de la probabilité que le patient aurait effectivement renoncé à l'acte s'il avait été prévenu.

Ce devoir d'information n'est pas une simple recommandation. Il est inscrit dans la loi. L'article L1111-2 du code de la santé publique en fixe le contenu.

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »

Source du texte : article L1111-2 du code de la santé publique,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137408

Un point capital pour vous : la preuve que cette information a bien été délivrée pèse sur le professionnel ou l'établissement, pas sur vous. Ce n'est pas à vous de prouver que vous n'avez pas été informé. C'est au soignant de

prouver qu'il vous a informé, par tout moyen. Cette règle rééquilibre un rapport de force naturellement défavorable au patient.

3. Le préjudice d'impréparation : réparer le choc de l'imprévu

La définition à retenir

Le préjudice d'impréparation est le préjudice moral qui naît lorsque le défaut d'information n'a pas permis au patient de se préparer psychologiquement à la survenue d'un risque qui s'est ensuite réalisé. Le patient a subi un dommage sans y avoir été préparé. Ce défaut de préparation est, en lui-même, un préjudice que le droit répare.

L'idée est humaine avant d'être juridique. Apprendre qu'un risque existe permet de s'y préparer, d'en parler à ses proches, d'organiser sa vie, d'accueillir l'épreuve autrement que par surprise brutale. Priver un patient de cette préparation, quand le risque finit par se réaliser, lui inflige une souffrance particulière : celle d'être frappé sans avertissement.

L'arrêt de principe : Cour de cassation, 23 janvier 2014

Ce préjudice a été consacré comme préjudice autonome par un arrêt de principe de la Cour de cassation. Voici sa référence exacte : Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123, Bull. 2014, I, n° 13.

La Cour y juge que :

« le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation »

Source de la décision : Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123, <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413>

Retenez la formule finale : ce préjudice, « le juge ne peut laisser sans réparation ». Autrement dit, dès lors que le défaut d'information est établi et que le risque s'est réalisé, le patient a droit à la réparation de ce préjudice d'impréparation. Le juge ne peut pas l'ignorer.

La confirmation : Cour de cassation, 25 janvier 2017

Cette solution n'est pas isolée. Elle a été confirmée par la suite. Référence exacte : Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898.

La Cour y qualifie ce préjudice de la manière suivante :

« un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé »

Source de la décision : Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898,
<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943617>

Notez la précision utile de cet arrêt : le préjudice doit être réparé « dès lors qu'il est invoqué ». Cela signifie qu'il faut le demander. Un préjudice d'impréparation non soulevé dans le dossier risque de ne pas être réparé. C'est une raison de plus de le connaître et de le faire valoir. Un patient bien accompagné n'oublie pas ce poste.

Le lien avec le devoir d'information

Le préjudice d'impréparation se rattache directement au devoir d'information de l'article L1111-2 du code de la santé publique, cité plus haut. C'est le manquement à ce devoir qui l'ouvre. Le professionnel devait vous informer des risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Il ne l'a pas fait. L'un de ces risques s'est réalisé. Vous n'aviez pas pu vous y préparer. Le préjudice d'impréparation est né.

4. Deux préjudices autonomes : ne les confondez pas

Voici le point de méthode le plus important de ce document. La perte de chance et le préjudice d'impréparation sont deux préjudices distincts et autonomes. Ils ne réparent pas la même chose. Ils obéissent à des conditions différentes. Ils peuvent, dans certains cas, se cumuler.

La perte de chance répare une occasion perdue : celle d'éviter le dommage ou d'y échapper. Elle suppose que, sans la faute, le patient aurait probablement connu un meilleur sort. Elle se répare en fraction, à hauteur de la chance perdue.

Le préjudice d'impréparation répare autre chose : le fait d'avoir subi un risque sans y avoir été préparé psychologiquement. Il ne suppose pas que le patient aurait refusé l'acte. Il ne se calcule pas en fraction d'un dommage physique. C'est un préjudice moral propre, qui existe par le seul fait que l'information n'a pas été donnée et que le risque s'est réalisé.

Un tableau vous aide à fixer la distinction.

CRITÈRE	PERTE DE CHANCE	PRÉJUDICE D'IMPRÉPARATION
Ce qui est réparé	La chance perdue d'éviter le dommage	Le choc de subir un risque sans préparation
Condition centrale	Une probabilité, sans la faute, d'un meilleur sort	Un défaut d'information, puis la réalisation du risque
Mode de calcul	Une fraction du préjudice total	Un préjudice moral autonome, évalué en propre
Faut-il un refus probable de l'acte ?	Oui, si la perte tient au défaut d'information	Non
Nature	Souvent lié à un dommage corporel	Préjudice moral distinct

L'exemple suivant montre comment les deux peuvent coexister. Un patient subit un acte sans avoir été informé d'un risque grave. Le risque se réalise et le laisse handicapé. Deux questions se posent alors, séparément.

Première question, celle de la perte de chance : correctement informé, ce patient aurait-il pu refuser l'acte et donc échapper au risque ? Si oui, il a perdu une chance d'éviter le dommage, réparée en fraction.

Seconde question, celle de l'impréparation : ce patient a-t-il subi le risque sans y avoir été préparé psychologiquement ? Oui, par définition, puisqu'il n'avait pas été informé. Ce préjudice moral existe indépendamment de la réponse à la première question.

Ces deux préjudices peuvent donc vivre côte à côte dans un même dossier. Les confondre, c'est risquer d'en oublier un. Or chacun se demande, chacun se prouve, chacun se répare. Un dossier bien construit les identifie tous les deux, les distingue clairement, et les fait valoir l'un et l'autre.

Une dernière précision de prudence. Ce document décrit des principes. Leur application à votre situation dépend des faits, de votre dossier médical et de l'expertise. La qualification exacte des préjudices, leur articulation et leur chiffrage relèvent de l'analyse de votre avocat.

Lexique

Perte de chance : préjudice né lorsqu'une faute a privé le patient d'une chance d'éviter le dommage ou d'y échapper. Il se répare à hauteur de la chance perdue, en fraction du préjudice total, jamais à 100 %.

Préjudice d'impréparation : préjudice moral né lorsque le défaut d'information n'a pas permis au patient de se préparer psychologiquement à la survenue d'un risque qui s'est réalisé. Préjudice autonome, consacré par la Cour de cassation le 23 janvier 2014.

Devoir d'information : obligation du professionnel de santé d'informer le patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles d'un acte, fixée par l'article L1111-2 du code de la santé publique. La preuve de l'information incombe au professionnel.

Nomenclature Dintilhac : liste de référence des postes de préjudice corporel, utilisée comme outil de travail par les experts et les tribunaux.

Consolidation : moment où l'état de santé se stabilise et n'évolue plus. Il sert de point de départ à plusieurs délais et à l'évaluation définitive des préjudices.

Votre prochaine étape Reprenez votre dossier médical et vos souvenirs de la consultation, et notez par écrit si les risques de l'acte vous avaient été expliqués, puis conservez cette note pour votre avocat.

Le contentieux médical se gagne sur la précision de ces distinctions. La perte de chance et le préjudice d'impréparation échappent souvent aux victimes qui affrontent seules leur dossier. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié à la réparation du dommage corporel et à la responsabilité médicale, aide les patients à identifier chacun de leurs préjudices et à les faire valoir. Si vous souhaitez faire examiner votre situation, une première consultation permet d'en parler et d'envisager la suite, sans engagement.

Le protocole de pré-analyse du dossier médical

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre, étape par étape, ce que le cabinet examine dans votre parcours de soins avant toute action. - Réunir en une seule fois les informations et les pièces médicales utiles à une pré-analyse rapide et fiable. - Savoir exactement ce que contient le rapport de pré-analyse remis sous 7 jours, et ce qu'il ne contient pas.

1. Pourquoi pré-analyser un dossier médical

Vous pensez avoir subi un dommage lié à un acte de soins. Avant d'engager quoi que ce soit, une question simple se pose : votre dossier tient-il debout sur le plan juridique ? La pré-analyse répond à cette question, et à elle seule.

En matière médicale, la responsabilité ne se présume pas. Un professionnel de santé n'est en principe responsable qu'en cas de faute (article L1142-1 du code de la santé publique). À côté de la faute, la loi prévoit d'autres voies : la responsabilité de plein droit de l'établissement pour une infection nosocomiale, c'est-à-dire une infection contractée à l'hôpital, et la réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, l'office public qui indemnise certains accidents médicaux non fautifs (article L1142-1 du code de la santé publique). Un même dommage peut relever d'un seul de ces fondements, ou d'aucun.

La pré-analyse sert donc à trier, très tôt, avant que vous n'investissiez du temps et de l'énergie. Elle ne vous promet aucun résultat. Elle ne déclare aucune faute. Elle vous dit si votre situation mérite d'être approfondie, et dans quelle direction.

Un repère de délai, d'abord. Les actions en responsabilité médicale et les demandes devant l'ONIAM se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage, c'est-à-dire à partir du moment où votre état de santé est stabilisé (article L1142-28 du code de la santé publique). Ce délai est long, mais il court. La pré-analyse vérifie où vous en êtes.

Constat de pratique. Les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réelle obtenue avec un avocat spécialisé.

Conformément à l'article 11.1 du Règlement Intérieur National, l'avocat est tenu à une obligation de moyens, non de résultat. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Chaque situation est unique.

2. Le questionnaire de collecte (partie client)

Répondez à ces 12 questions avec le maximum de précision. Une réponse approximative reste utile : indiquez « je ne sais pas » plutôt que d'inventer. Ces réponses orientent la lecture de votre dossier par le cabinet. Elles portent sur trois axes : votre parcours de soins, l'information que vous avez reçue, et vos séquelles.

Votre parcours de soins

1. Quel acte est en cause (intervention, diagnostic, prescription, suivi, accouchement) ? À quelle date a-t-il eu lieu, et dans quel établissement ou cabinet ?
2. Quel était le motif initial de votre prise en charge, et quel résultat en attendiez-vous ?
3. Comment votre état a-t-il évolué après l'acte ? Décrivez ce qui vous a alerté, et à quelle date.
4. Une infection est-elle survenue après une hospitalisation ou un acte ? Si oui, a-t-elle été nommée ou documentée par un médecin ?
5. D'autres médecins ont-ils été consultés ensuite ? Un praticien a-t-il évoqué, même oralement, un problème dans votre prise en charge ?

L'information reçue

6. Avant l'acte, vous a-t-on expliqué son utilité, ses alternatives et ses risques ? De quelle manière (oral, document signé, délai de réflexion) ?
7. Vous a-t-on remis ou fait signer un formulaire de consentement ? En avez-vous conservé une copie ?
8. Le risque qui s'est réalisé vous avait-il été annoncé avant l'acte ? Auriez vous accepté l'acte si vous l'aviez su ?

Vos séquelles

9. Votre état de santé est-il aujourd'hui stabilisé (consolidé), ou encore évolutif ? Si une date de consolidation a été fixée, laquelle ?
0. Quelles séquelles persistent (douleurs, limitations, retentissement psychologique) ? Depuis quand tenez-vous, si vous le faites, un journal de vos symptômes ?
1. Votre activité professionnelle, votre autonomie ou vos loisirs ont-ils été durablement affectés ? Avez-vous eu besoin de l'aide d'un proche au quotidien ?
2. Avez-vous déjà entrepris une démarche (réclamation, saisine, expertise, contact d'un assureur) ? Si oui, laquelle et à quelle date ?

Pièces à téléverser

Joignez, en format lisible (scan ou photo nette), les documents suivants lorsqu'ils existent. Vous avez le droit d'accéder à l'ensemble des informations de santé qui vous concernent : l'établissement doit vous les communiquer au plus tard dans les 8 jours suivant votre demande, délai porté à 2 mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans (article L1111-7 du code de la santé publique).

- votre dossier médical complet : comptes rendus opératoires, d'hospitalisation et de consultation, résultats d'examens, imagerie, ordonnances ;
- une chronologie écrite des faits, de votre main : dates, lieux, praticiens, événements marquants, dans l'ordre ;
- votre journal des symptômes s'il existe, même sommaire ;
- le ou les formulaires de consentement et documents d'information reçus avant l'acte ;

- les certificats médicaux, arrêts de travail et comptes rendus postérieurs à l'acte ;
- vos justificatifs de frais restés à votre charge, conservés ;
- toute correspondance déjà échangée avec l'établissement, un praticien ou un assureur ;
- le cas échéant, les attestations de proches établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile.

En cas de décès, les ayants droit peuvent obtenir les informations nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée de son vivant (article L1110-4 du code de la santé publique).

3. La trame du rapport de pré-analyse remis sous 7 jours

Le rapport vous est remis sous 7 jours ouvrés à compter de la réception d'un dossier complet. Il répond à trois questions, dans cet ordre, et à rien d'autre. Il ne qualifie aucune faute et ne chiffre aucune indemnité.

3.1 Première question : y a-t-il matière ?

Le rapport examine si votre dossier révèle un manquement plausible, c'est-à-dire un écart possible entre les soins reçus et ceux qui étaient attendus. Il croise votre récit, votre dossier médical et la chronologie. Il conclut par un avis prudent : matière possible, matière incertaine faute de pièces, ou absence d'élément exploitable en l'état.

Ce premier tri reste indicatif. La confirmation d'un manquement suppose l'avis d'un médecin-conseil, souvent au terme d'une expertise. Le rapport ne remplace ni l'un ni l'autre. Il ouvre ou referme une piste, il ne tranche pas.

3.2 Deuxième question : sur quel fondement ?

Si une matière est possible, le rapport indique le ou les fondements juridiques envisageables. Il en existe quatre, distincts, qui n'ouvrent pas les mêmes voies.

- **La faute.** Le professionnel n'est responsable des conséquences d'un acte de soins qu'en cas de faute (article L1142-1 du code de la santé publique). C'est le fondement le plus courant, et le plus exigeant à établir.
- **L'infection nosocomiale.** L'établissement répond de plein droit des infections contractées en son sein, sauf s'il prouve une cause étrangère (article L1142-1 du code de la santé publique). Lorsque l'infection entraîne une atteinte permanente supérieure à 25 % ou le décès, la réparation relève de la solidarité nationale (article L1142-1-1 du code de la santé publique).
- **L'aléa thérapeutique et l'ONIAM.** Un accident médical sans faute, présentant un caractère de gravité, peut être réparé au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM (article L1142-1 du code de la santé publique). Le seuil de gravité est fixé notamment à un taux d'atteinte permanente de 24 %, ou à un arrêt d'activité ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois (article D1142-1 du code de la santé publique).
- **Le défaut d'information.** Vous avez le droit d'être informé des risques fréquents ou graves normalement prévisibles d'un acte ; en cas de litige, la preuve que l'information a été délivrée incombe au professionnel (article L1111-2 du code de la santé publique). Lorsqu'un risque non annoncé se réalise, la jurisprudence répare un préjudice autonome, dit d'impréparation : le défaut d'information cause « un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation » (Cour de cassation, 1^{re} chambre civile, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123 ; confirmé le 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898).

Le rapport se borne à nommer le ou les fondements plausibles. Il ne conclut pas qu'un fondement est acquis. Cette qualification appartient à l'avocat, éclairé par un médecin-conseil.

3.3 Troisième question : par quelle voie ?

Le rapport indique enfin la voie de traitement la mieux adaptée, à titre d'orientation.

- **La voie amiable.** Une réclamation directe auprès de l'établissement ou de son assureur, lorsque le dossier s'y prête.
- **La commission de conciliation et d'indemnisation (CCI).** Toute personne s'estimant victime d'un dommage lié à un acte de soins peut saisir la CCI ; cette saisine suspend les délais de prescription et de recours jusqu'au terme de la procédure (article L1142-7 du code de la santé publique). La CCI est compétente au-delà d'un seuil de gravité, notamment un taux d'atteinte permanente de 24 % (article D1142-1 du code de la santé publique).
- **La voie judiciaire.** La saisine du tribunal, lorsque la nature du dossier ou l'attitude de l'adversaire le justifie.

Le rapport signale aussi, le cas échéant, les démarches préalables d'accès au dossier : recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs pour un établissement public (article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration), ou saisine du conseil de l'Ordre des médecins pour un praticien libéral (article R4127-46 du code de la santé publique). Ces pistes sont indiquées, jamais imposées.

4. Note interne : production du rapport

Cette section décrit le fonctionnement interne du cabinet. Elle est incluse par transparence.

Le rapport de pré-analyse est produit en semi-automatisation, au moyen des outils internes du cabinet (les skills LAWIA `lawia-evaluateur-prejudices` et `verificateur-references-legifrance`). Ces outils préparent la structure du rapport et vérifient la validité et l'actualité des références légales citées. Ils ne rendent aucune décision et ne qualifient aucune faute.

Chaque rapport fait l'objet d'une relecture et d'une signature systématiques de Maître Patrice Humbert avant remise. La part automatisée accélère la mise en forme et le contrôle des sources ; le jugement juridique et la responsabilité restent entièrement humains. Seul l'avocat, assisté d'un médecin-conseil, peut qualifier un manquement. C'est cette organisation qui rend le tarif tenable pour une prestation revue par un avocat spécialisé en dommage corporel.

Les conditions générales de vente qualifient ce livrable de prestation du cabinet. Toute suite éventuelle (accès au dossier, saisine d'une CCI, expertise, négociation, contentieux) relève d'une convention d'honoraires distincte, à laquelle les conditions générales renvoient expressément.

La qualification commerciale de cette prestation relève de la décision de Maître Humbert et de son Ordre. Le présent document ne préjuge pas de cette qualification.

Lexique

- **Consolidation** : moment où votre état de santé est stabilisé, sans amélioration ni aggravation attendue. Elle fait courir le délai de prescription et permet de chiffrer les préjudices définitifs.
- **Infection nosocomiale** : infection contractée au cours d'une prise en charge dans un établissement de santé.
- **Aléa thérapeutique** : accident médical survenu sans faute d'un professionnel.
- **ONIAM** : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui répare certains dommages au titre de la solidarité nationale.
- **CCI** : commission de conciliation et d'indemnisation, voie amiable de règlement des accidents médicaux au-delà d'un seuil de gravité.
- **Préjudice d'impréparation** : préjudice autonome subi lorsqu'un risque non annoncé se réalise, faute d'avoir pu s'y préparer.
- **Médecin-conseil** : médecin qui assiste la victime pour analyser le dossier médical et défendre ses intérêts, notamment en expertise.

Votre prochaine étape Rassemblez les pièces listées à la section 2, à commencer par votre dossier médical complet, puis téléversez-les avec vos réponses au questionnaire pour lancer votre pré-analyse.

Le cabinet LEXVOX AVOCATS accompagne les victimes de dommage corporel et d'erreur médicale dans les Bouches-du-Rhône et en région PACA. Une consultation initiale gratuite de 30 minutes permet de faire le point sur votre situation, sans engagement. Standard : 04 90 54 58 10. Site : <https://lexvox-victime.com>. Bureaux à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane.

Maître Patrice Humbert

AVOCAT AU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE · TOQUE 187 · SPÉCIALISTE CNB EN DOMMAGE CORPOREL
MASTER EN DROIT DE LA SANTÉ · FORMATION MÉDICALE EN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL
SELARL LEXVOX AVOCATS · 4 BUREAUX EN PACA · 04 90 54 58 10 · LEXVOX-VICTIME.COM

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15.